EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90886
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-20 14:00:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RODOLFO ANTONIO ROJAS SEPULVEDA			RUN	: 12.204.802-0
F.Nac	: 18-04-1972	Edad	: 52 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: COLVINDO			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: BLOQUEADO - INDEPENDIENTE	Teléfono	: 9/9278477		
Fecha Ingreso	: 2024-08-14	Fecha Egreso	: 2024-08-20 14:00:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ICH talamocapsular derecha 2 cc, ICH 1 (por HV), etiología obs HTA
-Obs sd ataxia-hemiparesia izquierdo
-AKI en regresión
-Déficit B12
-Ant: TBQ activo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable con HTA leve intermitente, RS al monitor, afebril, eupneico, tranquilo, refiere estabilidad en hemiparesia BC izquierda, tolera bien alimentación VO; durante KNTM regular control de tronco y marcha inestable.
Refiere haber debutado con parestesias distales de mano y pie izquierdos y luego hemiparesia BC izq súbita y disartria.
TC cerebro ingreso y control: HIC talamocapsular derecha, 2cc, con HV cuerno posterior VL ipsilateral, infarto antiguo centrosemioval derecho y dudoso centrosemioval izquierdo.
AngioTC cerebro y cuello: sin lesiones vasculares o malformaciones evidentes, hemorragia estable, sin HV.
Niega síntomas constitucionales previos.
Exs de lab de control destaca mejoría de función renal, ELP, elevación de troponinas en regresión (sin correlato clínico), B12 en límite inferior.
Diuresis(+), dep(-)
Destaca menor fuerza en EII respecto a examen previo, atribuible a edema vasogénico perihematoma transitorio.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio mañana martes para continuar rehabilitación kinésica ambulatoriamente en APS.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 20/8/24
-Rehabilitación kinésica en APS
-Control en policlínico de Neurología en 10-15 días
-Suspender tabaquismo
-Control HTA en APS

INDICACIONES AL ALTA

1. -Amlodipino 10 mg/día
2. -Hidralazina 50 mg c/6 horas
3. -Hidroclorotiazida 50 mg 1/2 comp al día
4. -Carvedilol 6.25 mg 1.5 comp c/12 horas

EXÁMENES Y RESULTADOS

18/8/24
-Crea 1.3 MDRD 57.97 Uremia 52
-CKMB 15 CK 107
-Na 138 K 4.6 Cl 102
-INR 1.01
-ProBNP 2167
-Trop 261

17/8/24
-Alb 3.6
-Crea 1.4 MDRD 53.22 Uremia
-AU 4.6
-Ca 8.9 P 3.8 Na 138 K 4.7 Cl 104
-FA 71 BI 0.76 BD 0.24 BT 1 GOT 38 GPT 22 GGT 76
-PCR <5
-Leu 5800 Hb 14.1 Plaq 136000 Seg 60 VHS 17
-INR 1.03
-Trop 308.9
-TSH 2.266 T4L 0.9
-B12 187 Folato 22.3
-RPR N/R

12/8/24
-Glic 117
-Alb 4.6
-Crea 1.6 MDRD 45.62 Uremia 35
-CKMB 24 CK 125
-LDH 219
-PCR <5
-Na 144 K 4.7 Cl 108
-Hb 15.2 Leu 8000 Plaq 173000 Seg 66
-INR 1 TTPA 32
-Trop 129.3
-OC N

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: conservado
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izquierda leve, hipoestesia facial izq leve, impresiona disartria leve, nistagmo(-), pares bajos N
-Motor: fuerza ESI M4-M4(+) proximal y M4(+) distal, EII M3-M4(-), BC der M5, RCP extensor izquierdo
-Sensibilidad: hipoestesia BC izq
-Cerebelo: dismetría BC izq que impresiona proporcional a paresia
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO